随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

## 二、强直性脊柱炎

肌肉附着地方

| | |
|---|---|
| 附着点炎（富强） | 粘在一起了 ttsx |
| 病变从**骶髂关节**开始<br>向上蔓延至**脊柱**<br>可同时向下蔓延至**髋关节、膝关节**<br>较少累及手关节（竹节伦能弹钢琴） | 有少数强直性脊柱炎病变始自颈椎，逐渐向下波及胸腰椎<br>易致上肢瘫痪和呼吸困难（预后差），称为 Bechterew 病<br>（B 在字母表排前面）<br>如果骶髂关节没有问题,绝对不要考虑强直性脊柱炎 |
| 骶髂关节影像学是诊断关键<br>**MRI** 能早期诊断（核磁/直） | **骶髂关节变窄、融合** 粘在一起了<br>脊柱呈**竹节椎** VS结核:有明显的骨质破坏,病变主要部位不是骶髂关节 |
| 慢性腰背痛，**驼背畸形**，**4 字试验**<br>**Schober 征**（削脖、看不到头了）<br>**HLA-B$_{27}$** | 为你弹奏（驼背的样子）肖邦（Schober 征）的夜曲（休息后加重）<br>纪念我死（4 字试验）去的爱情（HLA-B$_{27}$） |
| 治疗 | 非药物→NSAIDs、DMARDs→手术（脊柱截骨矫形术、关节置换术） |

位置高

4字是姑姑的盒子

休息后加重:①类风湿关节炎②强直脊柱炎③腕管综合症

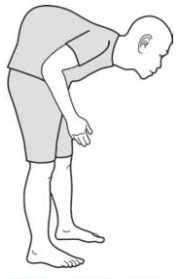


图 72-5 强直性脊柱炎驼背畸形



骶髂关节变窄融合



竹节椎

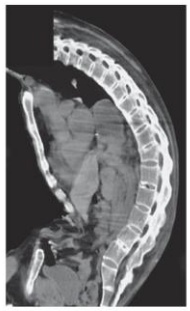


图 72-6 MRI 示脊柱呈竹节样改变



图 72-7 X 线片示髋关节呈骨性强直

### 专题串联 • 非化脓性关节炎鉴别诊断

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

| | 原发性骨关节炎 | 类风湿关节炎 |
|---|---|---|
| 病变始于 | **软骨** | **滑膜** |
| 好发年龄 | 中老年 | 青年 |
| 晨僵 | 多＜30 分钟 | 多≥半小时（内科）、≥1 小时（外科） |
| 好发部位 | 负重<br>**膝、髋、脊柱、远端指间关节，单侧为主** | 小关节**腕、掌指、近端指间关节，多发、对称** |
| 手部畸形 | **方形手、Heberden 结节、Bouchard 结节** | **天鹅颈样、纽扣花样、手关节尺侧偏斜** |
| 治疗 | NSAIDs、透明质酸钠，手术 | 同服 NSAIDs 或糖皮质激素+DMARDs，手术 |

激素不利于软骨修复　　改善病情的抗风湿药

| 强直性脊柱炎 | 类风湿关节炎 |
|---|---|
| 男青年多见 | 女青年多见 |
| 大关节多见 | **小关节多见** |
| **HLA-B$_{27}$** | **CCP、RF** |
| **休息后加重、活动后减轻**<br>（类风湿的晨僵明显而持久；竹节伦穿海澜之家（男人的衣柜）不停开演唱会、因为休息后会加重） | |
| 非药物→NSAIDs、DMARDs→手术<br>糖皮质激素对中轴关节病变无效 | 同服 NSAIDs 或糖皮质激素+DMARDs 如甲氨蝶呤<br>手术 |

骶髂关节、脊柱

VS 外周关节如髋关节、膝关节,可给激素